BASOCELULAR

Cáncer de piel más frecuente

BASOCELULAR

Variedad más común de basocelular

BASOCELULAR

Variedad de basocelular más agresiva

BASOCELULAR

Cirugía de elección en basocelular facial de alto riesgo

ESPINOCELULAR

Precursor más común del espinocelular

ESPINOCELULAR

Espinocelular in situ

ESPINOCELULAR

Úlcera de Marjolin

ESPINOCELULAR

Grupo con mayor riesgo de espinocelular agresivo

RESPUESTA · BASOCELULAR

Nodular: pápula perlada con telangiectasias.

RESPUESTA · BASOCELULAR

Carcinoma basocelular.

RESPUESTA · BASOCELULAR

Cirugía micrográfica de Mohs.

RESPUESTA · BASOCELULAR

Esclerodermiforme (morfeiforme).

RESPUESTA · ESPINOCELULAR

Enfermedad de Bowen.

RESPUESTA · ESPINOCELULAR

Queratosis actínica.

RESPUESTA · ESPINOCELULAR

Inmunosuprimidos (trasplantados).

RESPUESTA · ESPINOCELULAR

Espinocelular sobre cicatriz de quemadura o úlcera crónica.

MELANOMA

ABCDE del melanoma

MELANOMA

Factor pronóstico más importante

MELANOMA

Melanoma más frecuente en México

MELANOMA

Biopsia de elección ante sospecha de melanoma

TOXICODERMIAS

Toxicodermia más común

TOXICODERMIAS

SJS vs NET por superficie

TOXICODERMIAS

Fármacos clásicos de SJS/NET

TOXICODERMIAS

Medida más importante en SJS/NET

RESPUESTA · MELANOMA

Índice de Breslow (profundidad en mm).

RESPUESTA · MELANOMA

Asimetría, bordes, color, diámetro > 6 mm, evolución.

RESPUESTA · MELANOMA

Biopsia escisional con márgenes estrechos.

RESPUESTA · MELANOMA

Lentiginoso acral.

RESPUESTA · TOXICODERMIAS

SJS < 10 %; NET > 30 %; superposición 10–30 %.

RESPUESTA · TOXICODERMIAS

Exantema morbiliforme.

RESPUESTA · TOXICODERMIAS

Suspender el fármaco causal.

RESPUESTA · TOXICODERMIAS

Alopurinol, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, sulfas.

PÉNFIGOS

Antígeno del pénfigo vulgar

PÉNFIGOS

Nivel de la ampolla en pénfigo

PÉNFIGOS

Ampolla del penfigoide ampolloso

PÉNFIGOS

Inmunofluorescencia del penfigoide

ACNÉ

Lesión elemental del acné

ACNÉ

Tratamiento del acné comedónico

ACNÉ

Antibiótico oral en acné moderado

ACNÉ

Tratamiento del acné noduloquístico grave

RESPUESTA · PÉNFIGOS

Intraepidérmica suprabasal (acantólisis).

RESPUESTA · PÉNFIGOS

Desmogleína 3 (y 1).

RESPUESTA · PÉNFIGOS

Depósito lineal de IgG y C3 en la membrana basal.

RESPUESTA · PÉNFIGOS

Subepidérmica, tensa; Nikolsky negativo.

RESPUESTA · ACNÉ

Retinoide tópico.

RESPUESTA · ACNÉ

Comedón.

RESPUESTA · ACNÉ

Isotretinoína oral.

RESPUESTA · ACNÉ

Doxiciclina o minociclina, máximo 3 meses, con peróxido de benzoilo.

ROSÁCEA

Dato que distingue rosácea de acné

ROSÁCEA

Rinofima

ROSÁCEA

Tratamiento tópico de rosácea pápulo-pustular

ROSÁCEA

Ácaro relacionado con rosácea

DERMATITIS ATÓPICA

Proteína de barrera alterada en dermatitis atópica

DERMATITIS ATÓPICA

Distribución en el lactante

DERMATITIS ATÓPICA

Distribución en niños mayores y adultos

DERMATITIS ATÓPICA

Tratamiento en cara y pliegues para evitar esteroides

RESPUESTA · ROSÁCEA

Forma fimatosa de rosácea, más en hombres.

RESPUESTA · ROSÁCEA

La rosácea no tiene comedones.

RESPUESTA · ROSÁCEA

Demodex folliculorum.

RESPUESTA · ROSÁCEA

Metronidazol, ivermectina o ácido azelaico.

RESPUESTA · DERMATITIS ATÓPICA

Mejillas y superficies extensoras (respeta el área del pañal).

RESPUESTA · DERMATITIS ATÓPICA

Filagrina.

RESPUESTA · DERMATITIS ATÓPICA

Inhibidores de calcineurina tópicos (tacrolimus).

RESPUESTA · DERMATITIS ATÓPICA

Pliegues antecubitales y poplíteos.

DERMATITIS POR CONTACTO

Dermatitis por contacto más frecuente

DERMATITIS POR CONTACTO

Mecanismo de la dermatitis por contacto alérgica

DERMATITIS POR CONTACTO

Alérgeno de contacto más frecuente

DERMATITIS POR CONTACTO

Prueba diagnóstica de la dermatitis alérgica de contacto

PIODERMITIS

Lesión típica del impétigo

PIODERMITIS

Tratamiento del impétigo localizado

PIODERMITIS

Agente de la erisipela

PIODERMITIS

Ántrax cutáneo (estafilocócico)

RESPUESTA · DERMATITIS POR CONTACTO

Hipersensibilidad tipo IV.

RESPUESTA · DERMATITIS POR CONTACTO

Irritativa.

RESPUESTA · DERMATITIS POR CONTACTO

Prueba del parche (epicutánea).

RESPUESTA · DERMATITIS POR CONTACTO

Níquel.

RESPUESTA · PIODERMITIS

Mupirocina o ácido fusídico tópico.

RESPUESTA · PIODERMITIS

Costras melicéricas (color miel).

RESPUESTA · PIODERMITIS

Varios forúnculos confluentes; más en diabéticos.

RESPUESTA · PIODERMITIS

Streptococcus pyogenes.

LEPRA

Agente de la lepra

LEPRA

Lepra tuberculoide

LEPRA

Lepra lepromatosa

LEPRA

Tratamiento de la lepra (OMS)

ESCABIOSIS

Agente de la escabiosis

ESCABIOSIS

Lesión patognomónica

ESCABIOSIS

Tratamiento de elección

ESCABIOSIS

Sarna costrosa (noruega)

RESPUESTA · LEPRA

Paucibacilar; pocas placas anestésicas bien delimitadas.

RESPUESTA · LEPRA

Mycobacterium leprae.

RESPUESTA · LEPRA

Rifampicina + dapsona + clofazimina.

RESPUESTA · LEPRA

Multibacilar; lepromas, facies leonina, madarosis.

RESPUESTA · ESCABIOSIS

Túnel o surco acarino.

RESPUESTA · ESCABIOSIS

Sarcoptes scabiei.

RESPUESTA · ESCABIOSIS

Inmunosuprimidos; costras con miles de ácaros, muy contagiosa.

RESPUESTA · ESCABIOSIS

Permetrina 5 % de cuello a pies, repetir a los 7 días.

TIÑAS

Dermatofito más común en adultos

TIÑAS

Lesión de la tiña corporis

TIÑAS

Tratamiento de la tiña de la cabeza

TIÑAS

Examen directo para hongos

PITIRIASIS VERSICOLOR

Agente de la pitiriasis versicolor

PITIRIASIS VERSICOLOR

Imagen al KOH

PITIRIASIS VERSICOLOR

Fluorescencia con lámpara de Wood

PITIRIASIS VERSICOLOR

Tratamiento tópico

RESPUESTA · TIÑAS

Placa anular con borde activo descamativo y centro claro.

RESPUESTA · TIÑAS

Trichophyton rubrum.

RESPUESTA · TIÑAS

KOH: muestra hifas.

RESPUESTA · TIÑAS

Antifúngico oral (griseofulvina o terbinafina).

RESPUESTA · PITIRIASIS VERSICOLOR

Espagueti con albóndigas (hifas cortas y levaduras).

RESPUESTA · PITIRIASIS VERSICOLOR

Malassezia spp.

RESPUESTA · PITIRIASIS VERSICOLOR

Sulfuro de selenio o ketoconazol.

RESPUESTA · PITIRIASIS VERSICOLOR

Amarillo-dorada.

DERMATITIS SEBORREICA

Agente relacionado con dermatitis seborreica

DERMATITIS SEBORREICA

Costra láctea

DERMATITIS SEBORREICA

Zonas afectadas en el adulto

DERMATITIS SEBORREICA

Asociaciones de formas graves

PITIRIASIS ROSADA

Lesión inicial de la pitiriasis rosada

PITIRIASIS ROSADA

Patrón de distribución

PITIRIASIS ROSADA

Duración habitual

PITIRIASIS ROSADA

Diagnóstico diferencial principal

RESPUESTA · DERMATITIS SEBORREICA

Dermatitis seborreica del lactante en piel cabelluda.

RESPUESTA · DERMATITIS SEBORREICA

Malassezia.

RESPUESTA · DERMATITIS SEBORREICA

VIH y enfermedad de Parkinson.

RESPUESTA · DERMATITIS SEBORREICA

Piel cabelluda, cejas, surcos nasogenianos, orejas, preesternal.

RESPUESTA · PITIRIASIS ROSADA

Árbol de Navidad en el tronco.

RESPUESTA · PITIRIASIS ROSADA

Placa heráldica.

RESPUESTA · PITIRIASIS ROSADA

Sífilis secundaria.

RESPUESTA · PITIRIASIS ROSADA

6–8 semanas; autolimitada.

QUERATOSIS ACTÍNICA

Queratosis actínica: ¿precursora de qué cáncer?

QUERATOSIS ACTÍNICA

Clínica característica

QUERATOSIS ACTÍNICA

Tratamiento de lesión aislada

QUERATOSIS ACTÍNICA

Tratamiento de campo

NEVOS DISPLÁSICOS

Nevo displásico: significado

NEVOS DISPLÁSICOS

Aspecto típico

NEVOS DISPLÁSICOS

Herramienta de seguimiento

NEVOS DISPLÁSICOS

Indicación de biopsia

RESPUESTA · QUERATOSIS ACTÍNICA

Pápula eritematosa con escama áspera, mejor palpada que vista.

RESPUESTA · QUERATOSIS ACTÍNICA

Carcinoma espinocelular.

RESPUESTA · QUERATOSIS ACTÍNICA

5-fluorouracilo, imiquimod o terapia fotodinámica.

RESPUESTA · QUERATOSIS ACTÍNICA

Crioterapia con nitrógeno líquido.

RESPUESTA · NEVOS DISPLÁSICOS

Más de 5–6 mm, bordes irregulares, color variado, imagen en 'huevo frito'.

RESPUESTA · NEVOS DISPLÁSICOS

Marcador de riesgo de melanoma.

RESPUESTA · NEVOS DISPLÁSICOS

Cambio en la lesión o criterios ABCDE.

RESPUESTA · NEVOS DISPLÁSICOS

Dermatoscopia y mapeo fotográfico.

PSORIASIS

Signo de Auspitz

PSORIASIS

Fenómeno de Koebner

PSORIASIS

Psoriasis en gotas: antecedente

PSORIASIS

Tratamiento tópico de la psoriasis leve

LIQUEN PLANO

Las 6 P del liquen plano

LIQUEN PLANO

Estrías de Wickham

LIQUEN PLANO

Infección asociada al liquen plano

LIQUEN PLANO

Tratamiento de primera línea

RESPUESTA · PSORIASIS

Aparición de lesiones en sitios de trauma.

RESPUESTA · PSORIASIS

Sangrado puntiforme al retirar la escama.

RESPUESTA · PSORIASIS

Esteroide tópico + calcipotriol.

RESPUESTA · PSORIASIS

Infección estreptocócica faríngea.

RESPUESTA · LIQUEN PLANO

Red blanquecina sobre las pápulas o en mucosa oral.

RESPUESTA · LIQUEN PLANO

Pápulas planas, poligonales, purpúricas, pruriginosas, en placas.

RESPUESTA · LIQUEN PLANO

Esteroides tópicos potentes.

RESPUESTA · LIQUEN PLANO

Hepatitis C.